内科学含诊断学 循环系统疾病

考频（9-12 题，★★★）：A_1 3-5　A_2 3-6　B 0-2　X 1

①心肌疾病：肥厚型心肌病、扩张型心肌病、限制型心肌病、病毒性心肌炎
②心包疾病：心包积液、急性非特异性心包炎、缩窄性心包炎
③感染性心内膜炎
④高血压
⑤心瓣膜病：二狭、二闭、主狭、主闭
⑥冠心病：稳定型心绞痛、不稳定型心绞痛、急性心肌梗死
⑦心力衰竭：慢性心衰、急性心衰
⑧心律失常：房颤、室上速、室速、房室阻滞等　循环系统疾病损害了心肌的自律细胞
⑨心脏骤停

可以想成循环系统的三个并发症

注意：先复习《病理学》循环系统疾病相关章节，再复习内科学，并回顾式串联《生理学》

肥心病:肥厚的心肌细胞叫“胖胖不灵活”,主要影响舒张速度→回心血↓↓→没血可射
扩心病:由于遗传或免疫原因导致心肌细胞“挂掉了”→心肌收缩能力↓↓→有血射不出

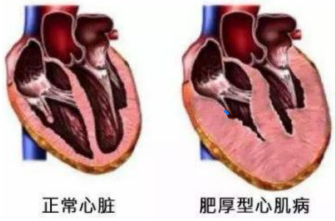
核心精讲·心肌疾病

（性感认识：肥心病没血可射 VS 扩心病有血射不出）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

左室流出道梗阻

一、肥厚型梗阻性心肌病

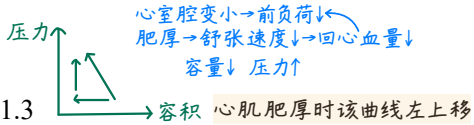


1.病因：常染色体显性遗传（常显肥）——肌球蛋白等编码基因突变：
①扰乱肌纤维排列（心肌细胞排列紊乱呈漩涡状）　肥厚型心肌病是青年人、运动员猝死最常见的原因
②心肌对 Ca^{2+} 敏感性增强→增加心律失常、猝死风险　钙超载会损害心肌
③横桥释放所需能量增加→心脏舒张功能↓

肌动蛋白 — 横桥 — 肌球蛋白　亲和力异常增高

二人亲三人分:与ADP结合时亲和力高,与ATP结合时亲和力低
所以横桥释放需要ATP

2.心脏特点
①心室明显不对称肥厚：尤其室间隔肥厚（15mm）、厚度室间隔/左室游离壁＞1.3
②左室流出道梗阻、心室腔变小（左室显著）、左室舒张末压力↑（胖胖不灵活）
③SAM 征：收缩期二尖瓣前叶向前移动与室间隔左侧心内膜接触（主动脉瓣下心内膜增厚）
④主要导致舒张性心衰（超声心动图 E/e’≥15、E/A＜1.2　大姨姨叫我小幺儿）



心室腔变小→前负荷↓←
肥厚→舒张速度↓→回心血量↓
容量↓ 压力↑

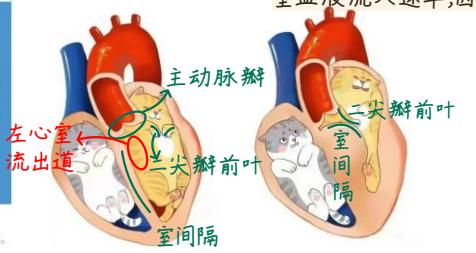
心肌肥厚时该曲线左上移
通过舒张产生负压,由于“胖胖不灵活”导致顺应性下降→舒张速度↓→左室舒张末压力↑

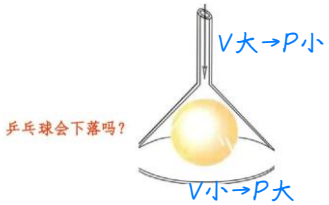
肌球蛋白突变→横桥释放所需能量增加→舒张性心衰,后期都会变成收缩性心衰
舒张障碍→负压抽吸回血↓→e↓→左心房代偿收缩(增强的第四心音)a↑

e:正常人在舒张早期,二尖瓣开放会产生较大的左心室血液流入速率(左心室的抽吸)
a:舒张晚期(左心房收缩)只会产生较小的左心室血液流入速率,因此正常情况e/a>1




图 9-28　肥厚型心肌病
室间隔非对称性肥厚,心室腔及左心室流出道狭窄。





3.临床特点　左室舒张末期压力↑→心房压力↑→肺静脉回流障碍　交感兴奋→心率加快→舒张期↓↓→充盈量↓↓→搏出量↓↓
①劳力性呼吸困难（最常见）、胸痛，运动低血压、晕厥
②可有心尖收缩期杂音　左心室流出道梗阻→射到主动脉根部血液↓→冠脉流量↓→胸痛
③胸骨左缘 3-4 肋间收缩期杂音，常喷射样：收缩期射血时血液流经狭窄的流出道
SAM现象→二尖瓣前移→二尖瓣关闭不全　左心室流出道梗阻会出现杂音,在室间隔的位置听诊